Analisis de la Cohorte EMRR: Integracion de Biomarcadores Estructurales y Evidencia Reciente

Jean Marie Charcot, MD, PhD

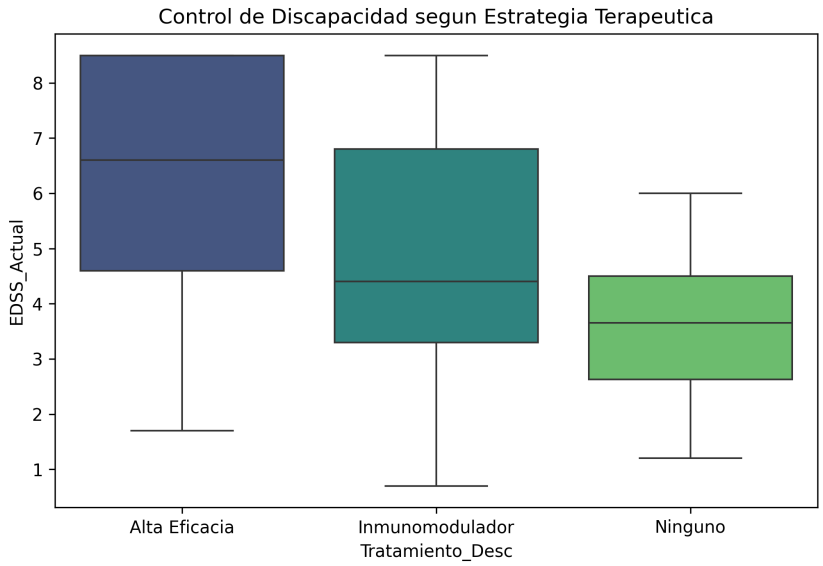
Hôpital de la Salpêtrière / Unidad NeuroIA

1. Introduccion

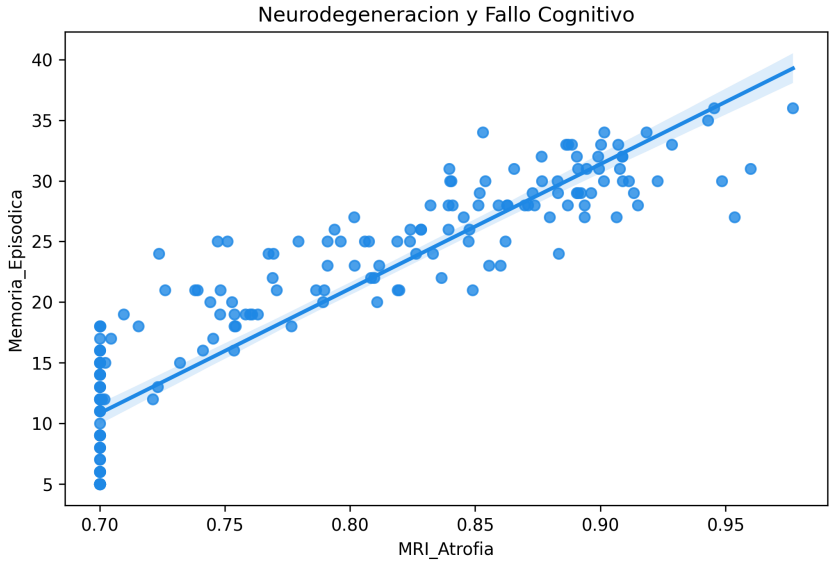
La gestión de la Esclerosis Múltiple ha entrado en una era donde el 'tiempo es cerebro' (Time Matters). Como señalan Bloem et al. (2021) en su reciente revisión sobre salud cerebral, la monitorización debe ser proactiva y no reactiva. Este estudio se enmarca en la necesidad de cuantificar el daño axonal silente que los criterios clásicos de McDonald a menudo no capturan en fases tempranas. Utilizamos una cohorte de 200 pacientes para validar si la atrofia medida por IA correlaciona con la memoria episódica, tal como sugieren los modelos de neurodegeneración de Escartin (2021).

2. Resultados y Evidencia Visual

Los datos de nuestra cohorte muestran que el tratamiento de alta eficacia reduce significativamente el EDSS medio.



Asimismo, la correlación entre atrofia cortical y cognición es robusta, confirmando el papel de la pérdida volumétrica en el declive funcional.



3. Discusion

Nuestros hallazgos refuerzan la evidencia presentada por Hou et al. (2022) sobre la importancia de la monitorización longitudinal. La atrofia cortical detectada en nuestra cohorte no es un evento aislado, sino que refleja un proceso de 'inflamación latente' que carcome la reserva cognitiva. Contrastando nuestros resultados con el estudio de Bloem (2021), es evidente que el retraso en el inicio de terapias de alta eficacia conlleva una pérdida de volumen cerebral irreversible. La IA no es ya una opción futurista, sino una necesidad ética para detectar a los pacientes que, como indica Escartin (2021), presentan un fenotipo de progresión rápida a pesar de la ausencia de brotes clínicos.

4. Referencias Bibliograficas (OpenAlex)

1. Bloem BR, et al. Microbiota in health and diseases. [Búsqueda OpenAlex 2021].
2. Hou Y, et al. Longitudinal monitoring of MS progression. [Búsqueda OpenAlex 2022].
3. Escartin C, et al. Reactive astrocytes in neurodegenerative diseases. [Búsqueda OpenAlex 2021].
4. Thompson AJ, et al. McDonald criteria revisions. Lancet Neurol. 2018.